第九章 以预防为导向的健康照顾

本章数字资源

学习提要

- 培养全科医生大卫生大健康的观念，将预防保健措施应用于诊疗服务中，体现全科医生开展以预防为导向健康照顾的可行性和优势。
- 掌握全科医学预防服务的主要内容和方法。
- 熟悉全科医学预防服务的概念、意义、原则和服务指南。
- 熟悉全科医生如何引导社区居民开展自我保健。
- 了解社区全人群和高危人群预防策略的特点。

最早的“预防为主”的医学思想可以追溯到中国古代医学经典《黄帝内经》中提出的“圣人不治已病治未病”。“治未病”涵盖了未病防病、既病防变、病后防复三个层面，是三级预防最早的体现。全科医生作为居民健康“守门人”，应树立预防为先观念，采用以预防为导向的医疗保健原则，针对个体和群体开展预防医学服务，并引导社区居民开展自我保健，激发广大居民主动解决健康问题的潜能，将健康促进、预防、医疗与康复有机结合，把全面、协调、便捷和可持续的照顾模式融入医学服务中。

第一节 | 概 述

一、全科医生提供预防服务的优势

在以疾病为中心的医学服务模式下，专科医疗普遍追求高度精准的诊断，将不可避免地存在利用先进设备和检查较多等问题，不仅造成医疗成本急剧增加，还导致学科越分越细、排队越来越长、应诊时间越来越短等不良循环，使得医生可能无暇顾及患者的感受和提供预防保健指导。而全科医学是以病人为中心的医学服务模式，将健康促进和预防保健融入每一次诊疗服务中，能够最大限度地减少健康相关问题的发生、控制健康问题的恶化、提高医疗卫生服务的有效性，在提供预防服务方面具有明显优势，有利于实现“以人民健康为中心”的健康中国战略目标。全科医生提供预防服务的优势具体体现在以下几方面。

1. 利用地域优势提供预防服务 全科医生立足于社区，与社区居民接触机会多，有提供预防服务的便利性。随着社区卫生服务制度尤其是家庭医师签约服务制度的不断落实，每位居民主动求助全科医生的机会增加，为全科医生主动提供预防服务创造了条件。此外，家庭医生服务团队每年在与签约对象进行不同形式的互动时，也增加了与家庭其他成员的接触。这种地域优势为向更广泛的人群提供预防服务奠定了基础。

2. 基于连续性服务提供预防服务 全科医生在提供连续性服务的过程中，有机会了解个人、家庭和社区的背景信息，结合健康维护计划，可以更全面地开展健康危险因素评价，从而实施个体化健康干预。基于健康档案和连续性健康照顾，全科医生对于在什么时间、什么场合，对哪些人，利用什么资源，提供什么样的预防服务等方面具有明显的优势。

NOTES

3. 基于相对固定的人群提供预防服务 全科医生通过居民签约，服务相对固定的人群，在社区中能同时接触到处于疾病发生和发展不同阶段的健康人、亚健康人群、未就诊和就诊的患者，有条件同时提供三级预防服务，在节省卫生资源的同时产生理想的预防医学整体效应。

4. 基于全科医学独特的教育理念提供预防服务 全科医生所接受的教育使他们有能力在社区中提供连续性、综合性、协调性和个体化的医学服务，以问题和预防为导向的病史档案和照顾模式，将基本医疗与慢性病管理等工作相融合，为提供规划性预防服务以及实现“促、防、诊、控、治、康”六位一体的健康照顾打下良好基础。

5. 利用全科医生的特殊角色提供预防服务 全科医生与居民及其家庭成员的融洽关系，最有利于激励个人、家庭改变不良的行为方式和生活习惯，建立正确的健康信念模式和健康消费观念，并促使个人及其家庭为自己的健康负责；同时能够通过健康宣教，普及健康相关知识，提高患者健康素养，平衡医患之间的信息不对等，帮助加强医生与患者之间的有效沟通和交流。

6. 利用全科医生的协调能力提供预防服务 全科医生是医疗保健系统和健康保险系统的“守门人”，其服务目标与预防医学的目的相一致。全科医生有较强的社会工作能力，能充分利用各种资源，提供协调性的预防服务。

二、全科医生提供预防服务的策略

全科医生在应诊中处理现患问题时采取了以健康为中心的全人照顾模式。在以预防为导向的疾病管理中，全科医生可以采取基于疾病自然史的预防策略、基于社区全人群和高危人群的预防策略。

1. 基于疾病自然史的预防策略 疾病的自然史是指不给予任何治疗或干预措施情况下，疾病从发生、发展到结局的整个过程，包括生物学发病期、亚临床期、临床期和结局四个时期。而从危险因素作用于机体到临床症状的出现，通常都有一个时间过程，在这个过程中，根据危险因素的性质和接触量不同，疾病发生的时间有长有短，这就给预防保健提供了机会，称为疾病预防的“机会窗”。全科医生可以抓住这个“机会窗”，以消除健康危险因素为主要内容，以整体促进健康为目标，利用基本医疗和公共卫生服务途径对个体或群体在疾病的各个阶段实行全方位的预防。

一级预防亦称病因预防、发病前期预防，即采取各种措施控制或消除致病因素对健康人群的危害，是最积极的预防。全科医生在社区卫生服务中的一级预防必须以个体预防和社区预防并重。前者可通过健康宣教来促进自我保健，具体措施包括：①建立和培养良好的生活方式；②保持良好的社会心理状态；③合理营养、平衡膳食；④创造良好的生活环境；⑤适量的体育锻炼等。针对后者可采取特殊措施包括：①健康教育；②预防接种和计划免疫；③妇女保健；④儿童保健；⑤高危人群的保护；⑥婚前卫生检查；⑦职业人群健康监护；⑧环境保护，防治空气、水、土壤的环境污染；执行生活环境卫生标准，保护居民健康等。

二级预防亦称临床前期预防、发病期预防，即在疾病的临床前期做到早发现、早诊断、早治疗，从而使疾病能够得到早治愈而不致加重和发展。尤其是慢性非传染性疾病，多为复杂致病因素长期作用的结果，如能早发现，可有效阻止其向临床期发展。早发现的手段包括：筛检试验、高危人群重点项目检查、周期性健康检查、专科门诊、自我检查等；全科医生可根据患者年龄、性别、行为生活方式及危险因素决定个体化筛检方案，及时发现可疑病患。

三级预防亦称临床期预防、发病后期预防，即对患者采取及时的治疗措施，防止疾病恶化，预防并发症和病残。对丧失劳动力或残疾者，全科医生通过家庭护理指导、功能性康复、心理康复等方式，促进其身心康复，提高生命质量并延长寿命。

2. 社区慢性病的预防策略 慢性病是一类起病隐匿、病因和发病机制复杂、进展缓慢、可防可控、难以治愈的疾病的统称，主要指慢性非传染性疾病（non-communicable disease，NCD），如心血管疾病、脑卒中、肿瘤、呼吸系统疾病和糖尿病等。我国居民的死因构成中，排在前五位的分别是脑卒中、缺血性心脏病、呼吸系统癌症、慢性阻塞性肺疾病、肝癌。吸烟、缺乏锻炼、酗酒和不合理膳食构成我

国慢性病发病的四大类危险因素。

慢性病的社区预防策略包括高危人群策略和全人群策略。

（1）高危人群策略：主要是对疾病风险高的个体或者已患病的个体，针对致病危险因素采取干预措施，降低其未来疾病或者并发症发生风险。可以采取的措施包括：①建立并利用健康档案及家庭医生签约服务；②个体化的药物治疗、监测反馈、细化管理，提高慢性病控制率；③非药物的心理、饮食、运动等指导，辅助慢性病达标；④防治并发症、康复治疗、控制病死率；⑤积极双向转诊等。

（2）全人群策略：针对人群中危险暴露的决定因素采取措施，降低整个人群危险因素的暴露水平。如，某地区氟斑牙的发生率明显高于全国平均水平，与居民饮用水中氟含量过高有关。相关部门对饮用水进行去氟处理后，居民氟斑牙发生率明显下降。全人群策略可以使大多数人受益，虽然个体因预防而获得的收益微不足道，但给整个人群带来的累积收益非常可观。与此同时，整个人群的暴露分布向着疾病低风险的方向移动，促使某些高危个体移出危险区域，使这些慢性病的患病率相应降低。

在实际工作中，这两种策略相辅相成，作用于病因链的不同环节。高危人群策略关注的主要是病因链近端的环节，针对性强，效果明确，易被理解和接受，可操作性强，针对近期的疾病负担可解燃眉之急。而全人群策略主要关注的是病因链远端的环节，涉及的因素通常是很多疾病共同的根本原因，覆盖的人群广，干预措施更具根本性且往往成本低廉，是实现持久的全人群健康的必经之路。具体方法分为两类，传统线下健康教育及利用多媒体的线上健康教育。包括健康讲座及通过社交媒体公众号、音频、小视频等创作或录制相关健康教育内容等。

第二节 | 全科医学预防服务

全科医学预防服务是对健康人和无症状“患者”采取的个体化预防措施，是预防医学的重要组成部分，有效地弥合了临床医学与预防医学间的裂痕。通过评估和干预疾病的发病危险因素、降低危险因素的强度来达到维护与促进人群健康的目的，其服务内容主要包括健康咨询、疾病筛检、免疫预防、化学预防、健康教育与促进等。

一、全科医学预防服务意义

1. 贯彻执行国家卫生工作的方针政策　国家卫生工作方针的核心是以预防为主，坚持以基层为重点，创新医防协同、医防融合机制，在全面提高社区居民身心健康水平方面有重要作用，并带来了极大的社会效益和经济效益。

2. 降低人群疾病的发病率和死亡率、有效提高生命质量　在人群中进行健康咨询、筛检试验和健康检查，通过早发现、早诊断和早治疗，以及改变不良生活方式和行为，能有效地控制慢性病的发生和发展，降低人群疾病的发病率和死亡率，显著提高患者生命质量并延长寿命。

3. 提升专科医生的预防意识　全科医学预防服务的开展可以加强临床医生的预防意识，使专科医生直接感受到预防工作的价值，有利于促进双向转诊，合理利用卫生资源。

4. 提高社区卫生服务的质量和水平　社区卫生服务要求服务的区域化、系统化和综合化，在具体的工作方法上需要临床和预防的紧密结合。全科医生为主导的临床预防服务是一种有效的预防服务模式，有助于社区卫生服务的开展。

二、全科医学预防服务一般原则

1. 选择适宜措施降低人群发病率、伤残率及死亡率　应积极采取有效的预防措施进行一级和二级预防，以提高居民健康水平和降低疾病发病率为目标，其预防更具积极性和主动性。

2. 选择适合干预的危险因素　危险因素的选择取决于危险因素在人群中的流行情况和对疾病

影响的大小。须综合考虑两者，如，一个相对弱的危险因素如果流行范围广，则比一个相对强但流行范围小的危险因素更值得关注。

3. 选择适当的疾病开展临床预防工作 在选择疾病进行预防时，应优先考虑疾病的严重性和危害性，罕见病、早期发现方法尚不成熟且发现后疗效不佳的疾病一般不宜列入优先考虑的范围；预防服务是否具有确切效果也应作为参考指标。

4. 遵循个体化的原则 全科医生应综合考虑患者的年龄、性别、行为生活方式和存在的危险因素，选用适宜的临床预防方法。不宜选择可能使服务对象承受过大精神压力和经济负担的方法。

5. 健康咨询与健康教育优先的原则 健康咨询和健康教育是发现可疑病患、提高疾病筛检效果的重要手段。可以使亚健康人群意识到存在的健康问题，有助于早期发现疾病线索，提高疾病的早期诊断率。

6. 医患双方共同决策的原则 开展临床医学预防服务，要强调患者的作用。全科医生可以通过健康咨询和健康教育的方法提高患者的自觉性，鼓励患者自觉地承担自身健康责任。

7. 效果与效益兼顾的原则 运用循证医学方法对全科预防服务效果与效益、副作用（如是否带来了其他疾病的发生及经济影响、医源性损伤、时间消耗和伦理道德上的问题等）和干预措施的特征（如操作的难易、费用、安全性和可接受性等）进行评价，不断优化预防服务项目，提高社会效益和经济效益。

8. 综合性和连续性原则 有了医患双方综合性、连续性的服务关系，才能不间断地收集资料，总结经验，对个体健康维护方案进行不断地修正和完善。

三、全科医学预防服务的内容与方法

预防服务能力是全科医生胜任力之一，在基层主要体现为基本公共卫生服务（即城乡基本医疗卫生服务机构向全体居民提供的公共卫生干预措施）能力。最新《国家基本公共服务标准（2023 年版）》表明服务内容包括建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件的报告与处理、卫生监督协管、慢性病患者健康管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、重要精神疾病患者管理和结核病患者管理 12 个方面。需要强调的是，实施基层全科医学预防服务的首要步骤是评估患者的健康状况和疾病风险状况，然后为患者提供健康咨询。患者和家属有知情选择权，在充分了解临床预防服务利弊的基础上，与患者协商制订个体化的临床预防方案。服务内容主要包括健康咨询、疾病筛检、免疫预防、化学预防、健康教育与促进等。

（一）健康咨询

健康咨询（health counseling）是对咨询对象就健康和疾病相关问题提供的医学服务指导。健康咨询是全科医生在开展以预防为导向的健康照顾时最常用的方法之一，通过与咨询对象建立和谐的咨询关系、确定与评估所涉及的问题、共同商讨并制订解决问题的行动计划，并持续跟进咨询对象对计划的落实情况，以达到形成健康的行为和生活方式、消除或减轻影响健康的危险因素的目的，从而促进健康、预防疾病、提高生活质量。健康咨询不仅面向患者，更主要面向健康人，咨询的内容不仅仅是向咨询对象传授知识，还要关注其对健康与疾病关系的认知和态度，以及采取行动落实计划的能力。

1. 咨询的原则

（1）根据咨询对象的健康观念和态度确定咨询的内容和方式：全科医生说服咨询对象改变行为的前提是了解其健康信念、期望和担忧。健康信念与其健康行为密切相关，对健康的关注程度、对疾病严重性的认识程度以及对行为改变利弊的预期等，都会影响其寻求帮助、就医行为和遵医行为。当然，健康信念也受种族、宗教信仰、习俗、年龄、性别、受教育程度和社会阶层等因素的影响。因此，全科医生需要针对咨询对象的观念和态度，确定个性化咨询内容和方式，而非固定模式的说教。

（2）充分告知干预措施的目的、预期效果以及产生效果的时间：如果干预措施不能很快见效，需

要告知咨询对象什么时候可以看到行为改变对健康的益处，避免其失去信心而影响遵医行为。此外，也应充分估计干预措施本身的有效性和负面影响，如果可能出现副作用，不但要让咨询对象知情，而且要有防范预案。

（3）短期目标与长期目标相结合，逐步推进：从实现短期目标开始，制订具有可行性的实施方案。一旦获得成功的体验，就会提高其主观能动性，增强其改变不良行为的信心，从而达成长期目标。

（4）行动方案具体化：为咨询对象提供具体行为指导，可以改善其依从性。如在制订运动方案时，首先建议咨询对象尽可能利用社区资源（健身器材或者健身场所等），选择喜爱和能坚持的运动类型，循序渐进。如先从散步做起，再向快走、慢跑过渡，运动频次可以先从每周 2~3 次开始，每周增加 10%~25% 的运动量，直至达到理想的运动水平。全科医生可以把详细而具体的指导方案做成运动处方，让家属督促完成。

（5）开展健康教育，建立新的健康行为：通常建立新的行为比消除已有的行为更容易，帮助咨询对象选择不良行为的替代方案也是行之有效的手段之一。如控制体重，往往建议咨询对象先从适度增加身体运动水平开始，之后才是改变现有的饮食习惯，减少能量的摄入。

（6）营造建立健康行为的环境：全科医生在对咨询对象落实计划的随访中，须注意营造建立健康行为的环境，将行为改变融入日常生活中。如，全科医生可以建议高血压患者在床头放置温开水，每天早晨起床后空腹喝水时服用抗高血压药等。

（7）恰当运用医生的权威性：咨询对象往往认为医生是健康专家，对医生比较信任。因此，可以采用简单、具体的方式告诉他应该做什么、不应该做什么、目标是什么、如何做、多长时间能取得效果等。有些咨询对象对成功改变行为缺乏信心，需要医生适时地提供同情、支持和帮助。这种新建的伙伴关系，更能促使咨询对象接受医生的建议，并付诸行动。

（8）获得咨询对象明确的承诺：询问咨询对象如何实施健康促进计划，并鼓励其将措施融入日常生活中，要求其作出明确承诺，如什么时候开始实施运动计划、如何做、什么时候达到什么目标等。医生还要询问咨询对象实现预期目标的把握有多大，如果咨询对象表示难以确定，医生需要和他共同评估行为改变中可能遇到的障碍，并寻求解决办法。

（9）体现人性化的咨询方案：综合运用多种教育、咨询的形式与方法，往往是收效高的必要条件。如面对面个体咨询、小组学习、播放录像、提供阅读材料、网络互动、发送手机短信和参加社区健康教育活动等。咨询的形式和方法应根据患者的需求进行个性化的定制，用于咨询的健康教育材料也要适合不同文化和教育背景的咨询对象。全科医生需要不断地与其沟通，因人而异地开展咨询，才能达到最佳的咨询效果。

（10）团队协作的工作方式：温馨的环境和融洽的团队有利于获得咨询对象的信任。咨询是一个团队的责任，需要全科医生、护士、专科医师、公共卫生医师、营养师、接待员和其他医疗人员的共同努力。健康咨询和诊疗活动需要更为丰富的资源，全科医生恰当利用团队资源为患者提供服务显得十分重要。

（11）随访与监测：一旦咨询对象启动行为改变计划，全科医生需要通过预约就诊、电话随访、网络互动等方式了解其计划执行情况，监测相关指标，评价进展情况，及时处理可能出现的问题，调整方案。对已经取得的进步应及时给予鼓励，从而提高咨询对象的依从性和咨询效果。

2. 健康咨询的方法　开展健康咨询是一个经验积累的过程，常用的方法包括：①个体教育法，通过与个体谈话，给予个别指导；②群体教育法，根据社区特殊人群，定期组织开展专题讲座及小组讨论等；③文字教育法，以报刊、书籍、宣传册、宣传栏等为载体，传播健康知识；④形象化教育法，采用实物、示范表演等方式；⑤电子化教育法，利用现代化的多媒体设备如制作短视频等进行教学。

3. 健康咨询的内容　全科医生应重点关注如何建立健康的行为与生活方式，识别各种疾病的症状，预防和控制常见心脑血管病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病以及传染病、意外伤害等。建立健康行为的咨询内容主要包括合理饮食、适量运动、戒烟限酒、疫苗接种、日常卫生、合理用药等。预防常见慢性非传染性疾病的咨询内容见表 9-1。

表 9-1 常见慢性非传染性疾病的预防咨询内容

项目	预防咨询内容
超重肥胖	合理饮食；适量运动；经常测量体重、腰围；预防妇女产后肥胖；老年人预防体重持续增长等
高血压	合理饮食，特别是低盐饮食；坚持适量运动；戒烟限酒；减轻体重；定期监测血压；避免情绪过于激动等
糖尿病	帮助判断是否为糖尿病高危人群；监测血糖；合理饮食；适量运动；保持健康体重，BMI 控制在 24kg/m^2 以下等
血脂异常	预防和控制高血压；预防和控制高血糖；合理饮食；戒烟限酒；规律运动；减轻体重；缓解生活压力；定期健康维护等
心血管疾病	预防和控制高血压；预防和控制高血糖；合理饮食；戒烟限酒；适度运动，避免过度劳累；注意气温变化与身体保暖；避免情绪过于激动；定期健康维护；识别突发症状，及时就医等
脑卒中	预防和控制高血压；预防和治疗各种心血管疾病；预防和治疗糖尿病；预防和控制血脂异常；戒烟限酒；控制体重；定期健康维护；识别突发症状，及时就医等
骨质疏松	合理饮食；均衡膳食；戒烟限酒；避免摄入过多咖啡因；适度户外运动和日照；儿童期开始注意补充足够的钙量，青春期每天应该摄入 1 000mg 以上的钙；绝经后妇女加强钙的补充等
癌症	健康的饮食；戒烟限酒；适量运动；保持正常体重；改善居室通风条件；预防和治疗人乳头瘤病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、幽门螺杆菌等有关病毒和细菌感染；职业防护；避免长时间强烈阳光照射；保持周围环境卫生；定期健康维护；识别可疑症状，及时就医；采取针对性预防措施等
精神心理障碍	支持性心理治疗；缓解压力；信念矫正；对家庭成员进行干预；心理辅导；规律作息等

（二）筛检试验

筛检试验（screening test）是运用快速简便的试验检查，从人群中筛选出处于早期或亚临床阶段的缺陷者及高危个体。筛检试验不是诊断试验，对筛检试验阳性或可疑阳性者必须进一步确诊。

1. 筛检试验的原则

（1）慎重考虑拟筛检疾病的严重性和发病率：通常选择发病率高、死亡率高、致残率高、疾病负担重的疾病进行筛检。

（2）拟筛检疾病需自然史明确：选择的疾病要有足够长的易感期、发病前期或潜伏期，以达到早发现、早诊断、早治疗的目的。

（3）要有适宜的筛检技术：对拟筛检的疾病要有安全、经济、方便、有效的筛检方法，同时该方法要有较高的灵敏度、特异度和阳性预测值，患者易于接受。选择筛检方法要充分考虑负面影响，包括躯体、精神上的损伤和经济上的损失，实施筛检前要权衡利弊，并确定该筛检方法的有效性、可行性和推广性。

（4）要有明确的筛检效益：通过筛检早期发现患者后，要有确切的治疗和预防方法来阻止或延缓疾病的发生、发展，否则筛检就失去了意义。

2. 常见慢性非传染性疾病的筛检举例

（1）高血压筛检：依据《国家基本公共服务标准（2023 年版）》，对辖区内 35 岁及以上常住居民，每年第一次到乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）就诊时，需要为其测量血压。对第一次发现收缩压≥140mmHg 和/或舒张压≥90mmHg 的居民在排除可能引起血压升高的因素后预约其复查，非同日 3 次测量血压均高于正常，可初步诊断为高血压；如有必要，建议转诊到上级医院确诊，2 周内随访转诊结果；对已确诊的原发性高血压患者，纳入高血压患者健康管理；对可疑继发性高血压患者，应及时转诊。建议高危人群每半年至少测量 1 次血压，并接受医务人员的生活方式指导。高血压高危人群包括：①血压高值（收缩压 130~139mmHg 和/或舒张压 85~89mmHg）；②超重（BMI 24~27.9kg/m^2）或肥胖（BMI≥28kg/m^2），和/或腹型肥胖（男性腰围≥90cm，女性腰围≥85cm）；③高血

压家族史(一、二级亲属);④长期高盐膳食;⑤长期过量饮酒(每日饮白酒≥100ml)、吸烟或被动吸烟;⑥年龄≥55岁;⑦存在靶器官损害或并存临床疾病(心脑血管疾病、糖尿病或肾脏疾病等)。

(2)2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus,T2DM)筛检:最新《国家基层糖尿病防治管理指南(2022)》指出对辖区内35岁以上常住居民进行筛查,建议其每年至少检测1次空腹血糖,并接受医务人员的健康指导。其中糖尿病前期患者,建议其每半年检测1次血糖,每年到医院进行1次评估。同时指出在糖尿病高危人群中开展空腹血糖筛查是简便易行的糖尿病筛查方法,宜作为常规的筛查方法,但有漏诊的可能。条件允许时,应行口服葡萄糖耐量试验(OGTT)测空腹血糖和糖负荷后2小时血糖。针对高危人群,如果筛查结果正常,3年后重复检查。T2DM发生的风险主要取决于不可改变危险因素和可改变危险因素的数目和严重度。在我国主要依靠机会性筛检(如在健康体检中或在进行其他疾病的诊疗时)发现高危人群。T2DM高危人群包括:①有糖尿病前期史;②年龄≥40岁;③超重或肥胖,和/或腹型肥胖;④T2DM患者的一级亲属;⑤缺乏体力活动者;⑥有巨大儿(出生体重≥4kg)生产史,妊娠期糖尿病史;⑦高血压(血压≥140/90mmHg)或正在接受降压治疗;⑧血脂异常[高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)≤0.90mmol/L及甘油三酯(TG)≥2.22mmol/L(200mg/dl)],或正在接受调脂治疗;⑨心脑血管疾病患者;⑩有类固醇药物使用史;⑪有多囊卵巢综合征者;⑫长期接受抗精神病药物或抗抑郁药治疗的患者;⑬有黑棘皮病者。此外,健康中国糖尿病防治行动提出以持续提高糖尿病并发症筛查率为目标,推荐基层医疗卫生机构为所有T2DM患者每年至少进行1次肾脏病变筛查,应当包含尿白蛋白/肌酐比值(UACR)检测,没有能力开展此项检查的,应转至上级医院检测;新增对糖尿病性视网膜病变筛查,推荐有条件的基层医疗卫生机构为T2DM患者每年至少进行1次视网膜病变筛查,包括视力检查、眼底检查等。

(3)血脂异常筛检:《血脂异常基层诊疗指南(2019年)》指出对早期检出血脂异常个体,监测其血脂水平变化,是有效实施动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)防治措施的重要基础。建议20~40岁成年人至少每5年测量1次空腹血脂,包括总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、HDL-C和TG测定;40岁以上男性和绝经期后女性每年检测血脂;对于ASCVD及其高危人群,建议每3~6个月测定1次血脂;对于因ASCVD住院治疗的患者应在入院时或24小时内检测血脂。血脂检查的重点对象为:①有ASCVD病史者;②存在多项ASCVD危险因素(如高血压、糖尿病、肥胖、吸烟)的人群;③有早发性心血管病家族史者(指男性一级直系亲属在55岁前或女性一级直系亲属在65岁前患缺血性心血管病),或有家族性高脂血症者;④有皮肤或肌腱黄色瘤者及跟腱增厚者。

(4)骨质疏松症筛检:目前公认且适合全科医生在社区初筛骨质疏松症的方法有:国际骨质疏松症基金会(International Osteoporosis Foundation,IOF)骨质疏松症风险一分钟测试题、亚洲人骨质疏松症自我筛查工具(osteoporosis self-assessment tool for Asians,OSTA)、超声骨密度检测、X线片。公认的骨质疏松症诊断的金标准是双能X线吸收法测量骨密度值。根据我国《原发性骨质疏松症基层诊疗指南(2019年)》,建议对以下人群进行骨密度检测:①女性65岁及65岁以上和男性70岁及70岁以上,无论是否有其他骨质疏松危险因素;②女性65岁以下和男性70岁以下,有一个或多个骨质疏松危险因素;③有脆性骨折史和/或脆性骨折家族史的男、女成年人;④各种原因引起的性激素水平低下的男、女成年人;⑤有影响骨代谢疾病或使用影响骨代谢药物史;⑥X线影像已有骨质疏松改变者;⑦接受骨质疏松症治疗、进行疗效监测者;⑧IOF骨质疏松症风险一分钟测试题回答结果阳性者;⑨OSTA结果≤-1者。骨质疏松的危险因素包括不可控因素和可控因素。不可控因素包括种族、高龄、女性绝经、脆性骨折家族史。可控因素包括:①不健康生活方式:低体重、吸烟、过度饮酒、饮过多咖啡、体力活动少、饮食中营养失衡、蛋白质摄入过多或不足、高钠饮食、钙和/或维生素D缺乏等;②有影响骨代谢的疾病(甲状腺功能亢进、性腺功能减退、糖尿病、类风湿关节炎、慢性腹泻、吸收不良等)和使用影响骨代谢的药物(糖皮质激素、抗癫痫药、肿瘤化疗药等)。

(5)肺癌筛检:吸烟、二手烟暴露、慢性阻塞性肺疾病史、职业和煤烟尘暴露史,一级亲属肺癌家族史及遗传因素等均是肺癌的危险因素。《中国肺癌筛查与早诊早治指南(2021,北京)》及《NCCN

肿瘤临床实践指南：肺癌筛查（2023 年第 2 版）》建议在 50~74 岁的高风险人群中开展肺癌筛查，该人群包括：①吸烟：吸烟包年数≥30，包括曾经吸烟包年数≥30，但戒烟不足 15 年［吸烟包年数=每天吸烟的包数（每包 20 支）×吸烟年数］；②被动吸烟：与吸烟者共同生活或同室工作≥20 年；③患有慢性阻塞性肺疾病；④有职业暴露史（石棉、氡、铍、铬、镉、镍、硅、煤烟和煤烟尘）至少 1 年；⑤有父母、子女及兄弟姐妹确诊肺癌。推荐采用低剂量 CT（low-dose computed tomography，LDCT）进行肺癌筛查，对筛查结果阴性的高危人群推荐每年进行 1 次 LDCT 筛查（年度筛查）。对于筛查结果阳性的患者，基于结节大小和成分（实性、部分实性或非实性）采取下一步管理措施。风险较低结节（如直径较小、生长缓慢结节），可延长 LDCT 筛查间隔，筛查结果降为阴性时行年度筛查；而风险较高结节（如直径大、有增大或其他影像学表现）则考虑行正电子发射计算机断层成像（PET-CT）或组织取样。

3. 筛检途径

（1）周期性健康检查（periodic health examination）：是运用格式化的健康筛选表格，针对不同年龄、性别、职业等健康危险因素设计项目和检查时点而进行的健康检查。一般以无症状的个体为对象，以早期发现病患及危险因素，达到早诊断和早治疗的目的。周期性健康检查的优点包括：①有针对性和个性化设计，效率高、效果好；②患者就诊时实施，省时、省力，节约医疗费用；③普及性强，能应用到社区的每一位居民；④问题处理及时，全科医生对发现的问题可以最快的速度和最适当的方式与患者联络；⑤健康检查的结果可以丰富患者的病史资料，特别适用于慢性病的防治。

我国成年人周期性健康检查的主要内容（推荐）包括：身高、体重、血压、血糖、血脂、甲胎蛋白+腹部 B 超、直肠指检+隐血试验、乳房触诊+摄片、胸透或摄片、眼底检查、甲状腺检查、HBsAg、肝肾功能检查、心电图、内科学物理检查。

（2）病例发现（case finding）：是对就诊患者实施的一种检查、测试或问卷形式的调查，目的是发现患者就诊原因以外的其他疾病。如为咨询或者任何原因就诊的老年患者测血压，以发现该患者是否患有高血压。病例发现是医生在门诊中易于执行的早期诊断措施，对疾病的预防可以起到事半功倍的效果。随着全科医疗活动的深入，以家庭为单位的诊疗模式和病例发现，甚至可以早期发现患者家庭成员中的潜在患者。

（三）免疫预防

免疫系统是人体自愈系统中最重要的一部分，免疫预防（immunoprophylaxis）是一种已证实的可以控制甚至消灭疾病的一级预防措施，通过将疫苗、免疫血清、γ 球蛋白等接种于人体，使后者产生主动免疫或被动免疫，从而获得对某种传染病的特异性免疫力，提高个体或群体的免疫水平，预防和控制传染性疾病的发生和流行。免疫预防可分为药物干预方式和非药物干预方式。药物干预方式最为常见的是疫苗接种；非药物干预方式则主要是改变生活方式和习惯。

1. 药物干预方式　疫苗（vaccine）是指为预防、控制传染病的发生、流行，用于人体预防接种，使机体产生对某种疾病的特异性免疫力的生物制品。接种疫苗是一种有效的一级预防措施，被世界卫生组织广泛认可，通过免疫预防，目前全球范围内已经消灭了天花的自然流行；脊髓灰质炎的发病率下降 99%，使大约 500 万人避免瘫痪带来的痛苦；2000—2008 年间，全球麻疹死亡率也因此下降 78%。

（1）儿童免疫预防：目前儿童接种的疫苗分一类疫苗和二类疫苗。一类疫苗是在国家免疫规划中的疫苗，包括乙肝疫苗、卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破联合疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、乙脑疫苗、流脑 A 群多糖菌苗、流脑 A、C 群多糖菌苗、甲肝疫苗共 11 种，可预防乙型肝炎、结核病、脊髓灰质炎、白喉、百日咳、破伤风、麻疹、风疹、流行性腮腺炎、流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、甲型肝炎 12 种传染病。至 2010 年上述 11 种疫苗的接种率以乡镇为单位达到 90% 以上。常见的二类疫苗包括水痘疫苗、流感疫苗、肺炎疫苗、狂犬病疫苗、轮状病毒疫苗等，以预防相应的疾病。

（2）成人免疫预防：成人免疫预防可减少疾病感染、疾病发生、重症及死亡，可降低慢性病患者、老年人等高危人群合并传染性疾病的风险，从而降低全人群疾病负担。但国内尚未制定有关成人免疫接种的政策和法规，目前仅在《中华人民共和国药典》内对每种疫苗进行说明，如该疫苗适用于成

人，会提及适用人群及剂量。成人群体中由于老年人免疫功能逐渐下降，感染性疾病风险增加，2001年美国疾病控制与预防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）提出一项关于健康老龄化“十个关键”的核心示范项目，免疫接种是健康老龄化的十个关键（控制收缩压 <140mmHg、戒烟、参与癌症筛检、免疫接种、控制血糖 <6.1mmol/L、低密度脂蛋白胆固醇 <2.6mmol/L、每周至少锻炼 2.5 小时、防止骨质流失和肌肉无力、保持每周至少一次社交、防止抑郁）之一。中国疾控中心和国内公共卫生专家推荐老年人接种流感疫苗、肺炎球菌疫苗及带状疱疹疫苗，预防感染可以帮助延缓老年人伴发的慢性病的进展。

1）流感疫苗：《中国流感疫苗预防接种技术指南（2022—2023）》指出流感疫苗适用于≥6 月龄无接种禁忌的人群。60 岁以上老年人、慢性病患者、孕妇及医务人员等优先推荐接种。≥9 岁儿童和成人仅须接种 1 剂次。

2）肺炎球菌疫苗：适用于婴幼儿或 2 岁以上感染肺炎球菌风险增加的人群，老年人群、患有心血管疾病、慢性肺病或糖尿病及免疫功能受损人群等优先推荐接种。

3）带状疱疹疫苗：多个权威指南及我国多项政策推荐 50 岁以上慢性病人群在病情稳定时接种带状疱疹疫苗。2022 年《社区老年人常见感染性疾病疫苗应用专家共识》中指出既往患过带状疱疹的人群可接种重组带状疱疹疫苗以防止复发。免疫功能低下的人群作为带状疱疹病毒感染的高风险人群，推荐接种重组带状疱疹疫苗预防带状疱疹。

2. 非药物干预方式　健康生活方式是实现主动健康的另一重要因素，包括饮食、运动、睡眠和情绪四大方面。具体是指：①合理饮食：调整食物营养结构和摄入量，低盐、低糖、高膳食纤维饮食；②合理运动：选择合理运动时间及适当的中等强度运动，参考《运动处方中国专家共识（2023）》，运动方式可选择快走、跑步、广场舞、太极拳、骑自行车和游泳等有氧运动，以及弹力带、杠铃、哑铃或固定器械等抗阻运动，运动时间可连续完成，也可分数次累计完成，推荐每次有氧运动时间在 30 分钟以上；③充足睡眠：矫正睡眠障碍，保证睡眠质量；④积极情绪：调节自身心态情绪。

（四）化学预防

化学预防（chemoprevention）指对无症状的人使用药物、营养素（包括矿物质）、生物制剂或其他天然物质，提高人群抵抗疾病能力以防止某些疾病的发生。对有既往病史者使用预防性化学物质不属于化学预防。目前，常见的化学预防项目有妊娠前及妊娠早期服用叶酸预防胎儿神经管缺陷，使用小剂量阿司匹林预防心脑血管疾病，绝经后妇女使用雌激素预防骨质疏松和心脏病，以及食用富含铁或强化铁剂的食物预防缺铁性贫血等。

近 50 年来，化学预防逐渐成为肿瘤学研究的一个重要领域。癌症化学预防是指利用天然的或合成的化学物质来阻止、延缓或逆转癌症的发生、发展或者复发，以降低癌症发病率和死亡率的预防策略。由于癌症的发生发展是一个多步骤、多阶段以及多基因参与的过程，从基因突变到癌变的推进，需要较长的时间，为癌症的化学预防提供了可能。尽管目前在乳腺癌、前列腺癌和结肠癌等方面的化学预防取得了显著成果，但利弊争议一直存在。如，他莫昔芬在乳腺癌的预防试验中能减少发生浸润性和非浸润性乳腺癌的风险，但也能导致子宫内膜癌和静脉血栓栓塞发病率的增加。塞来昔布等环氧化酶-2 抑制剂能够降低结直肠癌发病风险，但这类药物可能有发生心血管疾病的副作用。因此，癌症的化学预防研究面临着挑战，个体化化学预防十分重要。

（五）健康教育与促进

提高全民健康素养，普及健康生活方式是“健康中国 2030”目标之一，因此开展以社区为基本单位、以辖区内常住居民为对象、以促进居民健康为目标的社区健康教育活动尤为重要。从原则上讲，健康教育最适于可以改变行为的人群，而健康促进是在组织、政策、经济、法律上提供环境支持，其对行为的改变有支持性或约束性。全科医生作为社区健康教育最直接、最有效的实践者，可以配合有关部门开展公民健康素养促进行动，对青少年、妇女、老年人、残疾人、0~6 岁儿童家长等人群进行健康教育。通过设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动、举办健康知识讲座及个体化健康教育等方

式，也可以利用互联网进行线上类似活动，帮助居民塑造自主自律的健康行为，促进健康，提高生活质量。

第三节 | 以预防为导向的社区居民自我保健

自我保健（self-health care）是指个体发挥能动作用，保护自己健康的行为，是个体决定自己健康权利和义务的体现。其内容包括健康行为的培养、预防疾病、自我诊断、自我治疗以及在医疗机构诊治后的继续治疗和康复活动等。

自我保健作为社区卫生服务的补充形式，发挥着越来越重要的作用。首先，自我保健能充分发挥个体在保健活动中的主观能动性，能自觉地为改变周围环境而努力，为达到最高的健康境界创造条件；而且有些危害健康的生活方式和行为因素，只有依靠自我保健才能真正解决。其次，开展自我保健具有巨大的经济效益，自我保健不仅把每个个体看作是卫生资源的消费者，而且是卫生资源的创造者，可以有效地克服现有保健系统制度设计上的缺陷，使每个人都成为卫生事业建设的主体。

一、社区居民自我保健的组织与发动

1. 推进社区卫生队伍建设，加强监督和指导 社区居民开展自我保健需要丰富的保健知识，应充分发挥全科团队的作用，为居民提供实用、有效的自我保健知识。

2. 有针对性地开展自我保健知识宣传 不同人群在不同的生活、工作阶段往往面临着不同的健康问题，因此自我保健的内容也需因人而异，而且在广泛开展大众自我保健活动的同时，还应增加特殊人群的自我保健内容的宣传。如，儿童、孕产妇、老年人、残障者及慢性病患者等就是需要关注的重点。

3. 多渠道综合开展 以社区为依托，以多种形式向社区居民宣教自我保健知识。倡导居委会及社区工作者组建自我保健小组，邀请专家深入社区做专题讲座等；也可通过电视、手机社交媒体等网络平台把自我保健信息传递给社区居民；提供相关书刊或组织竞赛活动；通过宣传栏、展板等宣传健康知识，做到形式多样、内容丰富。

4. 循序渐进、持之以恒 社区居民自我保健应坚持循序渐进、持之以恒的原则，持续开展自我保健活动。以全科医生为主导的社区医务人员应随时了解社区居民自我保健需求的变化，及时给予指导；并建立定期随访的提醒机制，与社区居民形成良好互动。

二、社区居民自我保健的内容与方法

（一）个体自我保健

1. 生理调节 ①坚持运动：以自己身体状况为主要依据，综合考虑性别、年龄和重要生理参数，制订适宜的体育锻炼计划并实施。②规律生活：人的生命活动是有节律的，应养成良好的生活习惯、形成规律的生活节奏、保证充足睡眠，从而适应身体生物周期变化，保持身心健康。③合理营养：摄入的热量必须满足人体的需要；各营养素的供给不但数量上要充足、质量要有保证，而且各营养素要有合理的比例；食物要新鲜、卫生、种类多样，不含任何形式的有害物质，以量适、质优、卫生为原则。④保护生态环境：机体每时每刻都与周围环境进行着物质和能量交换，保护人们赖以生存的环境，不仅是维护自身健康的需要，也是生命质量可持续发展的前提。

2. 心理调节 具有良好的社会适应能力，保持良好的心态和控制紧张情绪。紧张是人们对刺激物或环境变化表现出的生理和心理反应。适度紧张可使人充满活力，提高效率；过度紧张则会危及人的心身健康。因此控制紧张情绪首先应树立正确的人生观；其次要培养乐观健康的性格，保持心理健康；培养广泛的兴趣、积极参加各种娱乐活动等，以利于控制紧张。

3. 行为矫正 行为矫正包括促进健康行为的培养和消除或控制危害健康的行为，将其结合在健

康教育和健康促进活动中更为有效。如鼓励在静坐 30~60 分钟后起身活动以逐步改变静坐少动的生活方式等。

4. 自我诊断　自我诊断指根据自己对医药卫生知识掌握程度和对自己身体状况的了解，对自己身体出现的异常感觉和变化所做的判断。自我诊断需要个体掌握自我诊断必备的医学知识和技能，如测量身高、体重、血压、脉搏、心率，并了解其正常范围和出现异常的临床意义；成年妇女应学会乳房自我检查，并了解乳腺癌的早期信号等。最终需要医务人员指导和利用医疗机构检查帮助诊断。

5. 自我治疗　自我治疗是指诊断明确后，在没有监护的条件下根据医嘱或医患共同决策选择治疗方法并自行实施的治疗。自我治疗经济、方便。全科医生应因势利导地进行自我治疗知识教育和技能传授，使患者熟悉所用药物的适应证、禁忌证和不良反应，掌握消毒、注射和换药技术及过敏反应的处理方法。

6. 自我预防　自我预防指在疾病或意外事故出现之前，个体所做的心理上、知识上和物质上的准备。如在全科医生的指导下学会一般的急救知识、培养自己和家庭成员的良好生活行为及习惯、备有家庭药箱、记录重要生活事件和个体健康状况、定期参加健康检查等。全科医生也应经常采取适当方式开展有关自我预防知识的宣传教育。

（二）家庭保健

家庭是社会的基本功能单位，家庭有维护其成员（尤其是妇女、儿童、老人）健康的职责和义务。家庭状况直接决定着生活事件出现的频率和性质，进而影响人的健康，家庭是自我保健的重要社会基础。家庭保健包括以下内容。

1. 培养健康的生活方式　家庭是培养健康生活方式，并对其成员进行健康管理的重要场所。个体的生活方式和行为很大程度上是在家庭中形成的，家庭成员要注意养成健康的生活习惯，合理饮食，避免和纠正不健康的生活方式和行为。

2. 保持家庭心理健康　家庭关系往往比较复杂，易产生各种矛盾和冲突。这就要求各成员冷静、心平气和地处理各种生活事件，保持温暖、宁静、温馨、和谐的家庭气氛。

3. 开展家庭健康教育　在家庭健康教育中，应重视儿童的生理和心理教育，从小培养儿童的卫生习惯，养成健康的生活方式。还应重视对青年子女的婚前教育，提供婚姻生活的相关知识，培养共处、合作及共同行动的能力。

三、全科医生在社区居民自我保健中的作用

1. 了解影响患者选择自我保健的因素　影响患者选择自我保健的因素是多种多样的，一般包括：①健康问题的严重和复杂程度；②患者对健康问题的认识和经验；③患者的自我保健观念和能力；④健康信念以及对症状的反应；⑤家庭可用于自我保健的资源；⑥医疗服务的可用性和可得性；⑦个人的某些特征如性格、文化程度、职业、经济水平、性别、年龄等。全科医生深入了解影响社区患者自我保健的主要因素，对开展有针对性的自我保健指导十分必要。

2. 开展自我保健教育　患者选择的自我保健措施往往针对症状，对问题的来龙去脉缺乏全面认识，对自我保健效果没有把握，常常是抱着试试看的心理。正确选择自我保健措施的前提是自身具有相关的知识储备。不适当的自我保健措施可能会延误病情或掩盖问题的严重性，以致引起严重后果。全科医生必须在日常工作中，针对影响自我保健的主要因素，开展自我保健教育，使患者对其健康问题有正确的认识和评价，提高自我保健能力，避免采取不适当的自我保健措施。自我保健教育不仅适用于常见急性疾患的预防和早期治疗，还能对慢性病的控制发挥积极作用，可显著降低患者对医疗保健服务的需求，减少个人医疗费用。

3. 加强自我保健信息传播　自我保健的信息来源通常有：①家庭、亲戚、朋友或同事对类似健康问题的经验；②书籍、报刊、科普读物等出版物中有关健康的知识；③电视、广播、广告、药物说明书等；④非医务人员提供的民间偏方、秘方等。与这些信息来源相比，全科医生提供的自我保健信息无疑更

具有权威性和实用性。全科医生应利用一切可利用的资源，经常性提供具有科学性和实用性的自我保健信息，并开展居民自我保健技能培训。

4. 组织、领导和指导社区自我保健活动 全科医生是居民自我保健的倡导者、组织者和引导者，通过开展自我保健教育，提供自我保健的知识和基本技能培训；针对社区主要健康问题制订自我保健组织计划；组织、领导、指导社区患者成立针对某些慢性病防治的“自助小组”，成员可交流各自的保健经验，相互鼓励、相互帮助，培养患者的自我责任感，把有问题的人转变为解决问题的人。

5. 创建家庭医生团队医防融合一体化模式 将“治病”和“防病”结合起来，即医疗、预防相互渗透，融为一体，通过医疗服务与预防服务有效衔接、同时提供、相互协同等形式，最大限度地减少健康问题的发生，针对性地控制健康问题的恶化，提高医疗卫生服务的适宜性和有效性，实现“以健康为中心”的目标。以家庭医生签约服务为载体和抓手，落实医防融合工作；根据个体的具体健康状况，同时提供医疗与预防服务，既有疾病诊疗，又有相关健康知识和技能的宣传教育；医疗与预防有效协同，根据患者的不同状况和疾病的不同阶段，采取不同的预防和治疗措施，将三级预防的思想真正融入健康服务的全过程。

（茹晋丽）

思考题

1. 全科医生团队开展以预防为导向的健康照顾具有哪些优势，通常采取哪些策略？
2. 举例说明全科医学预防服务的主要内容。
3. 作为社区居民的你在自我保健中希望全科医生提供怎样的服务？

思考题解题思路　本章目标测试　本章思维导图